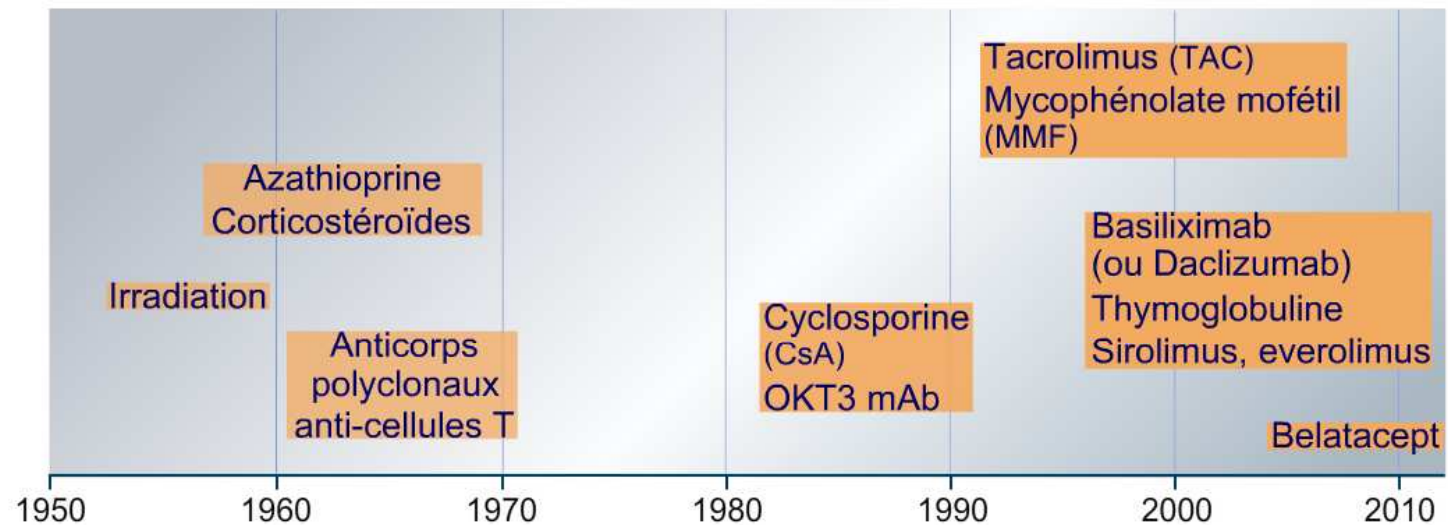


Transplantation
rénale



Transplantation d'organes et thérapies immunosuppressives

Tendances
actuelles



Wong W et al. *Transplantation* 2005 ; 80 : 289-96
Wong W et al. *Transplant Int* 2006 ; 19 : 629-635
Golshayan D et al. *Transplant Int* 2007 ; 20 : 12-24

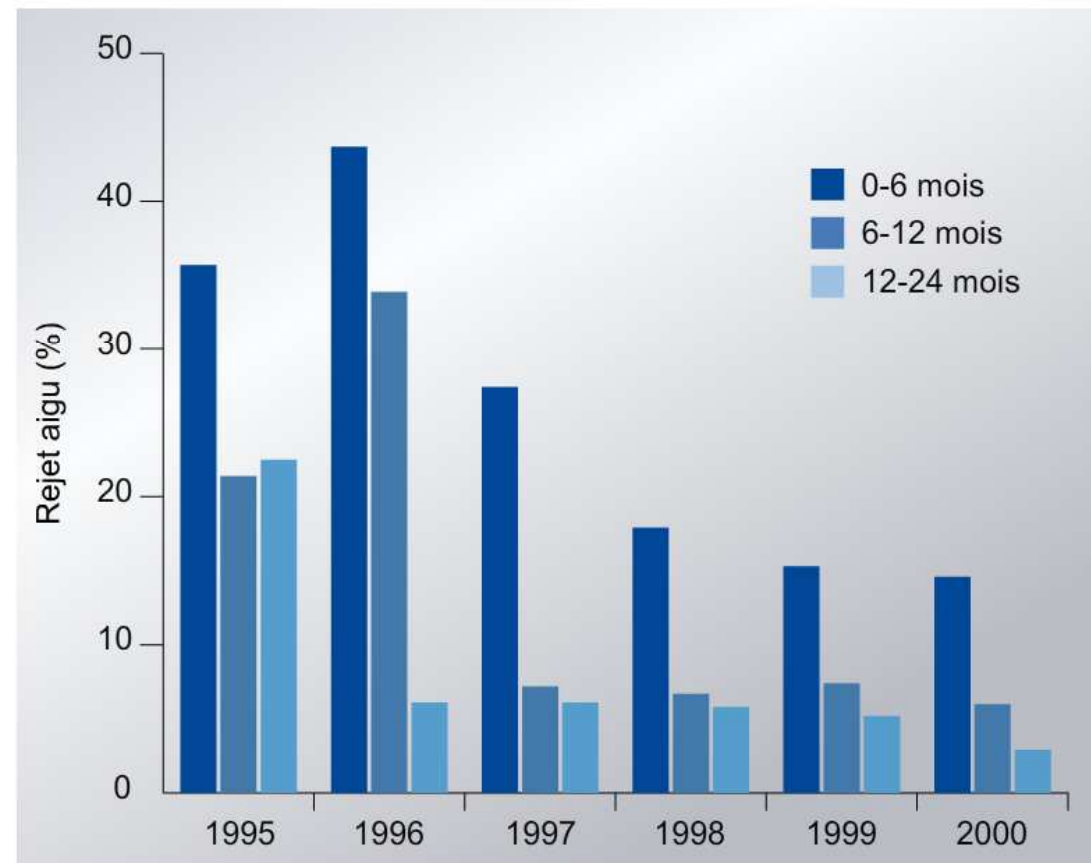
Transplantation rénale



Incidence décroissante d'épisodes de rejet aigu de 1995 à 2000

Données du registre scientifique US de receveurs d'organes

Tendances actuelles



Meier-Kriesche HU et al. Am J Transplant 2004 ; 4 : 378-83

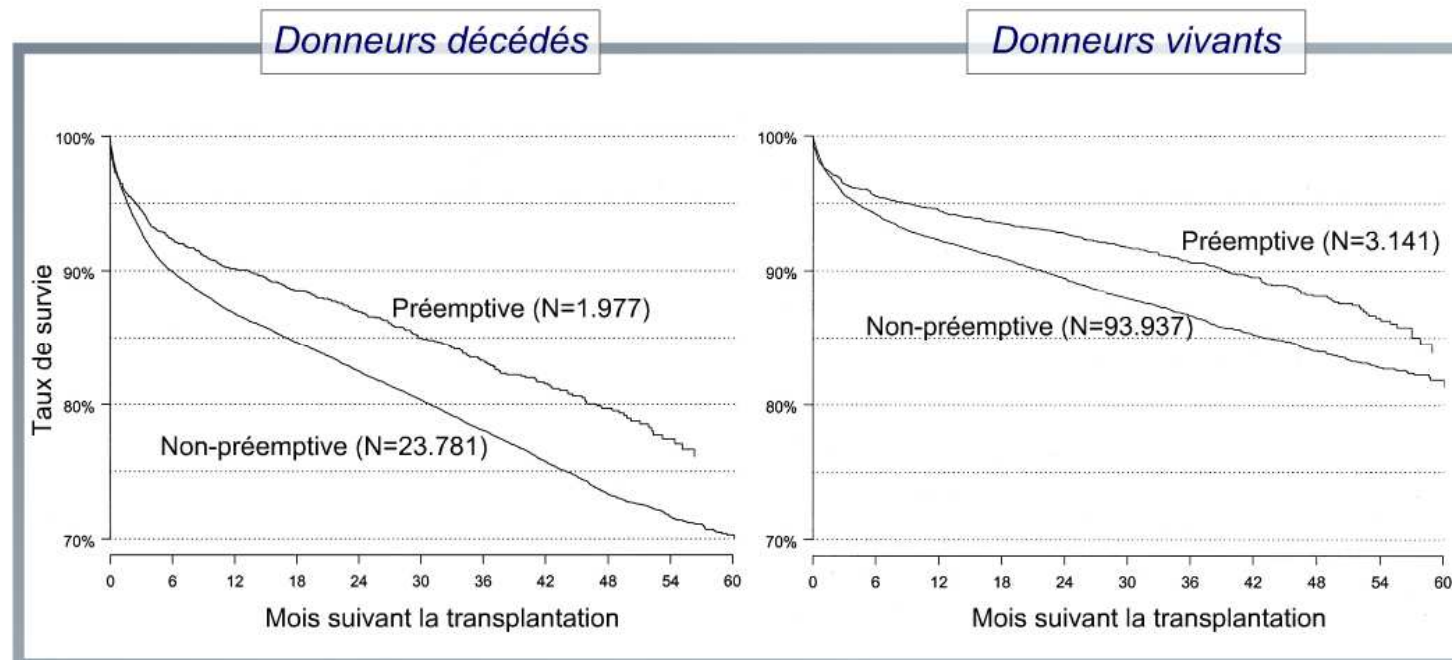
Transplantation rénale



Taux de survie suite à une greffe de rein

Préemptive versus non-préemptive

Tendances actuelles



Kasiske B et al, JASN 2002 ; 13 : 1358-1364

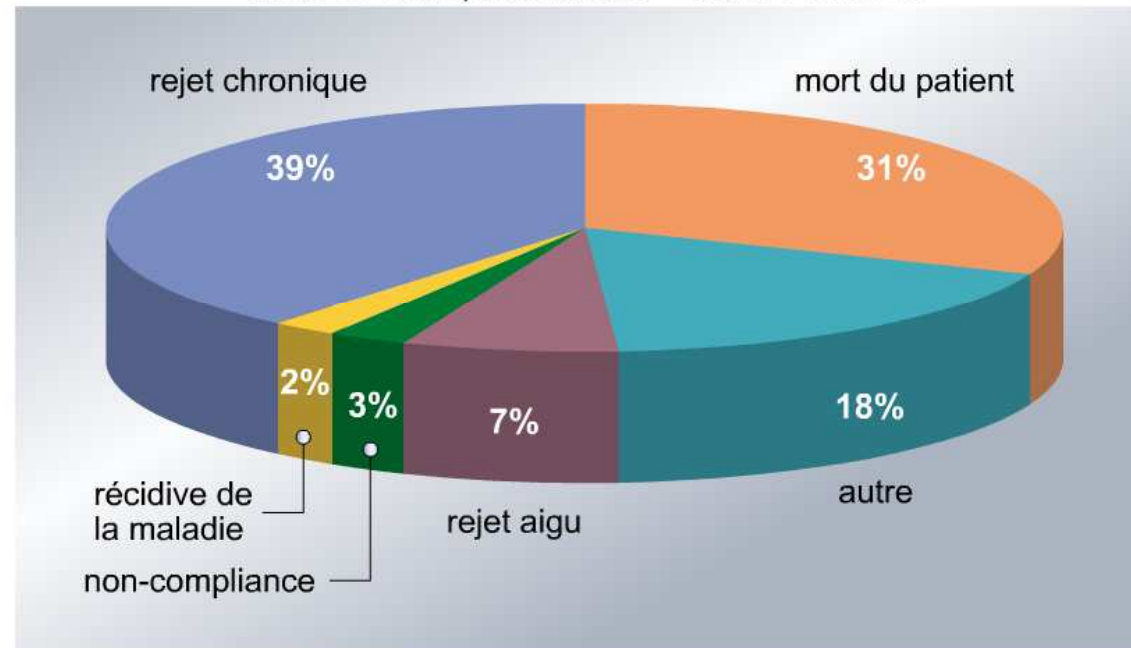
Transplantation rénale



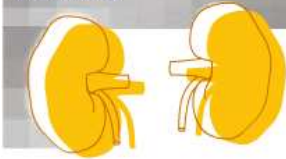
Causes d'échecs de greffes de rein après la première année d'une transplantation rénale

Tendances actuelles

120,000 transplantations – 15,000 échecs



Pascual M et al. N Engl J Med 2002 ; 346 : 580-90
et données du "United Network for Organ Sharing" (US)



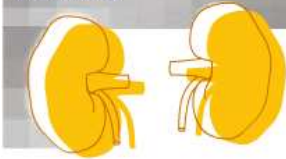
**Comment
améliorer
les résultats
à long-terme ?**

**Quelle est la stratégie optimale d'utilisation des agents
immunosuppresseurs ?**

Question importante :

Est-ce que les CNIs (cyclosporine ou tacrolimus) peuvent être interrompus ou réduits au minimum afin de diminuer les risques de "néphropathie chronique d'allogreffe" et ainsi obtenir de meilleurs résultats?

(CNI : calcineurin inhibitor)

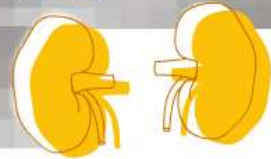


**Comment
améliorer
les résultats
à long-terme ?**

Patients avec fonction rénale stable, plus d'une année après la greffe

- > Une réduction de 30 à 50% du dosage de CNI peut être la meilleure stratégie à long terme pour éviter les effets secondaires des CNI sans augmenter le risque de rejet (CsA / prednisone / MMF).
- > Il est nécessaire de faire plus d'études de **suivi à long terme** pour définir la dose optimale de cyclosporine ou de tacrolimus (c'est-à-dire éviter la néphrotoxicité tout en évitant le rejet).

*Pascual M et al. Transplantation 2003 ; 75 : 1501–5
Golshayan D and Pascual M Transplant Immunology 2008*



**Comment
améliorer
les résultats
à long-terme ?**

Cyclosporine ou tacrolimus?

> A court terme?

CsA-ME versus tacrolimus (Etude européenne, n=560)

> Avec tacrolimus :

- Moins de rejet aigu, moins d'hypertension et moins d'hypercholestérolémie
- Plus de tremblements et d'hypomagnésémie
- Pas de différence de PTDM (défini par le besoin d'insuline > 30 jours)
(PTDM : *post-transplant diabetes mellitus*)
- Cependant des études récentes (2007) montrent légèrement plus de PTDM ou d'intolérance au glucose avec le tacrolimus.

Margreiter R et al. *Lancet* 2002 ; 359 : 741–6
Vincenti F et al. *Am J Transplant* 2007 ; 7 : 1-9

Transplantation rénale

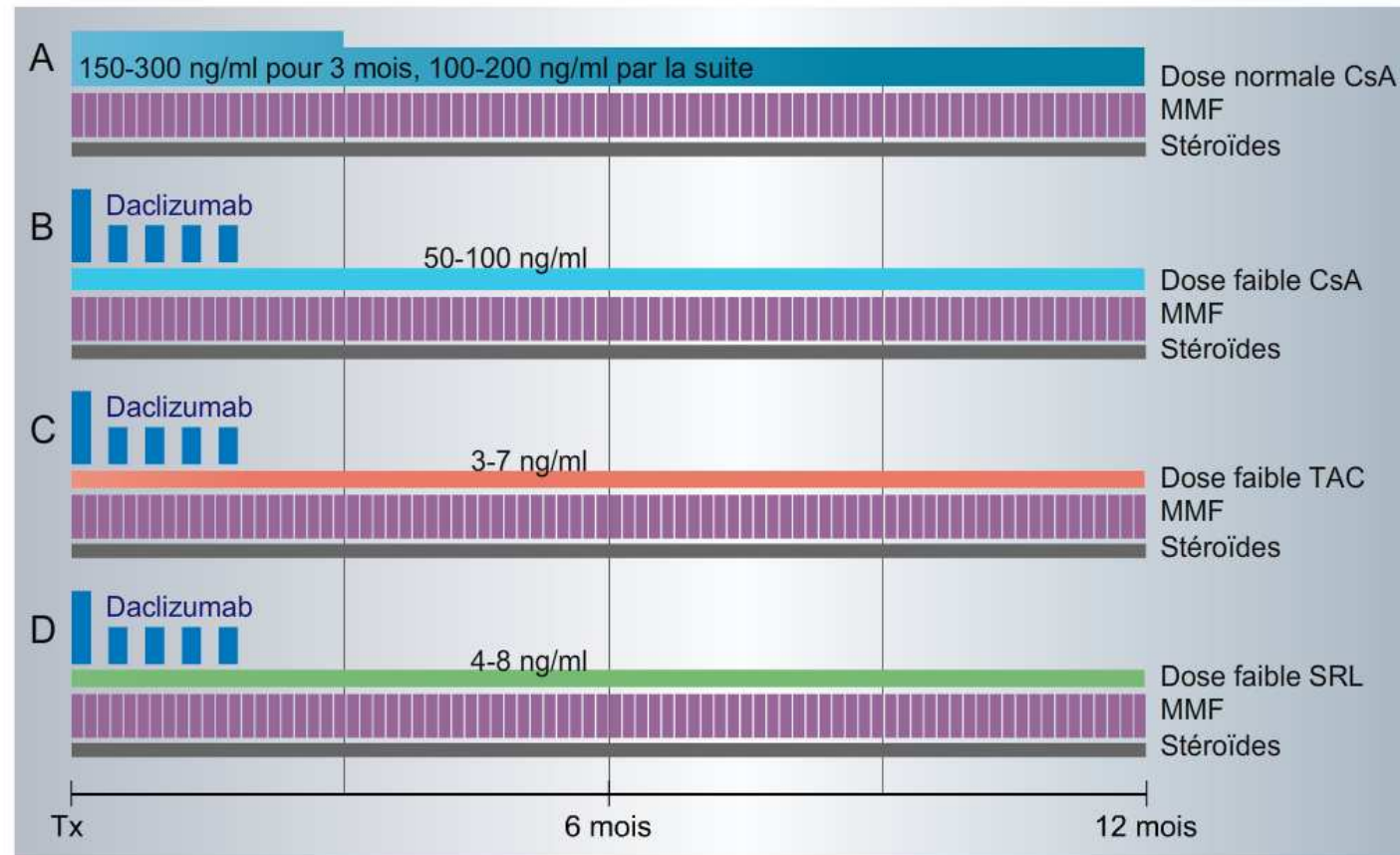


Etude "Symphony"

Design (n = 1645 patients enrôlés)



Comment
améliorer
les résultats
à long-terme ?



Tx: greffe CsA: Cyclosporine A MMF: Mycophénolate mofétil
TAC: Tacrolimus SRL: Sirolimus

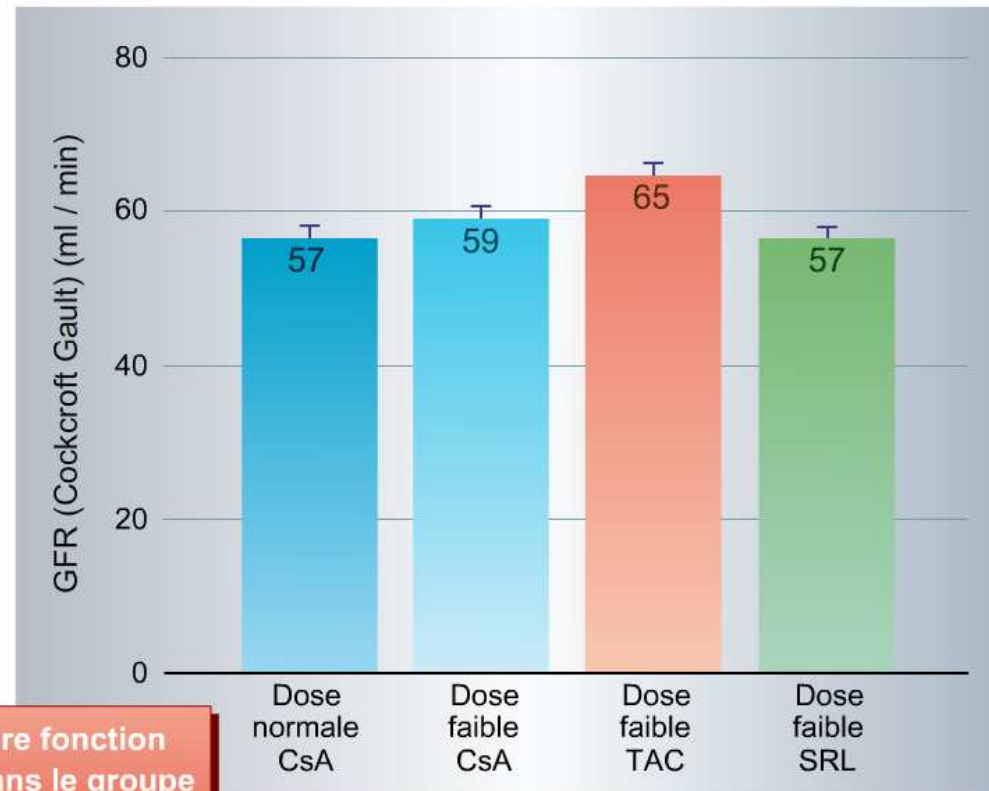
Ekberg H et al. NEJM 2007
Am J Transplant 2009

Transplantation rénale



Fonction rénale (GFR ; Cockcroft-Gault) à 12 mois post-transplantation

Comment
améliorer
les résultats
à long-terme ?



Meilleure fonction
rénale dans le groupe
"Dose faible TAC"

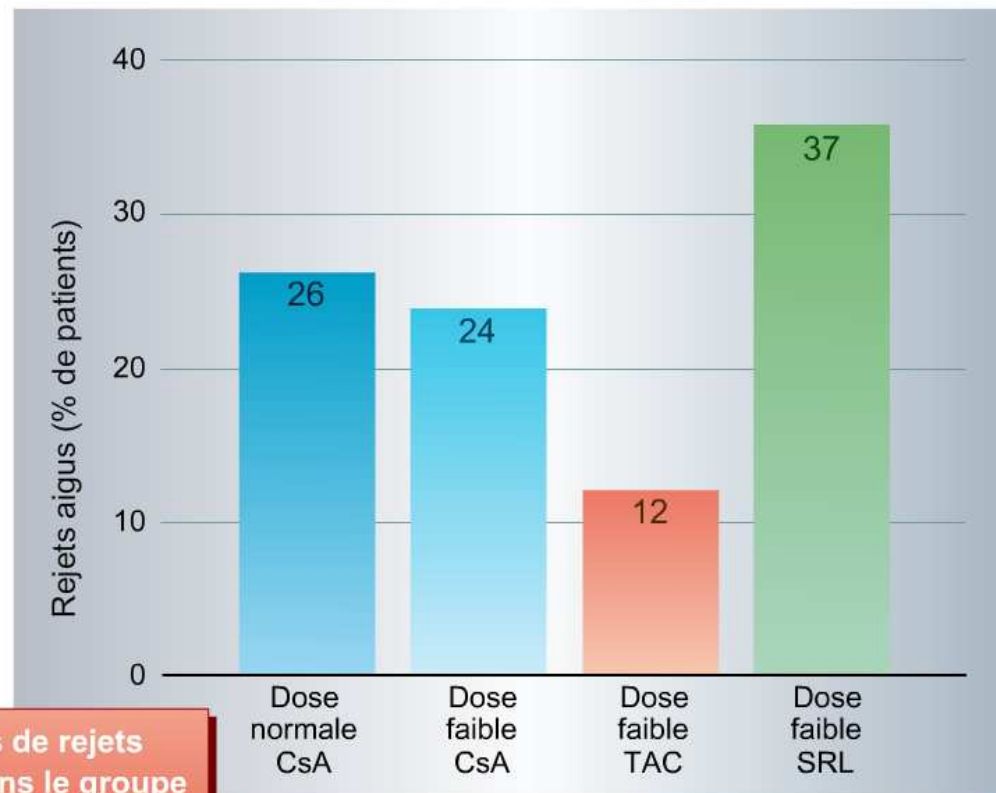
Ekberg H et al. NEJM 2007
Am J Transplant 2009





Rejets aigus (biopsiés) à 12 mois post-transplantation

Comment
améliorer
les résultats
à long-terme ?



Moins de rejets
aigus dans le groupe
"Dose faible TAC"

Ekberg H et al. NEJM 2007
Am J Transplant 2009



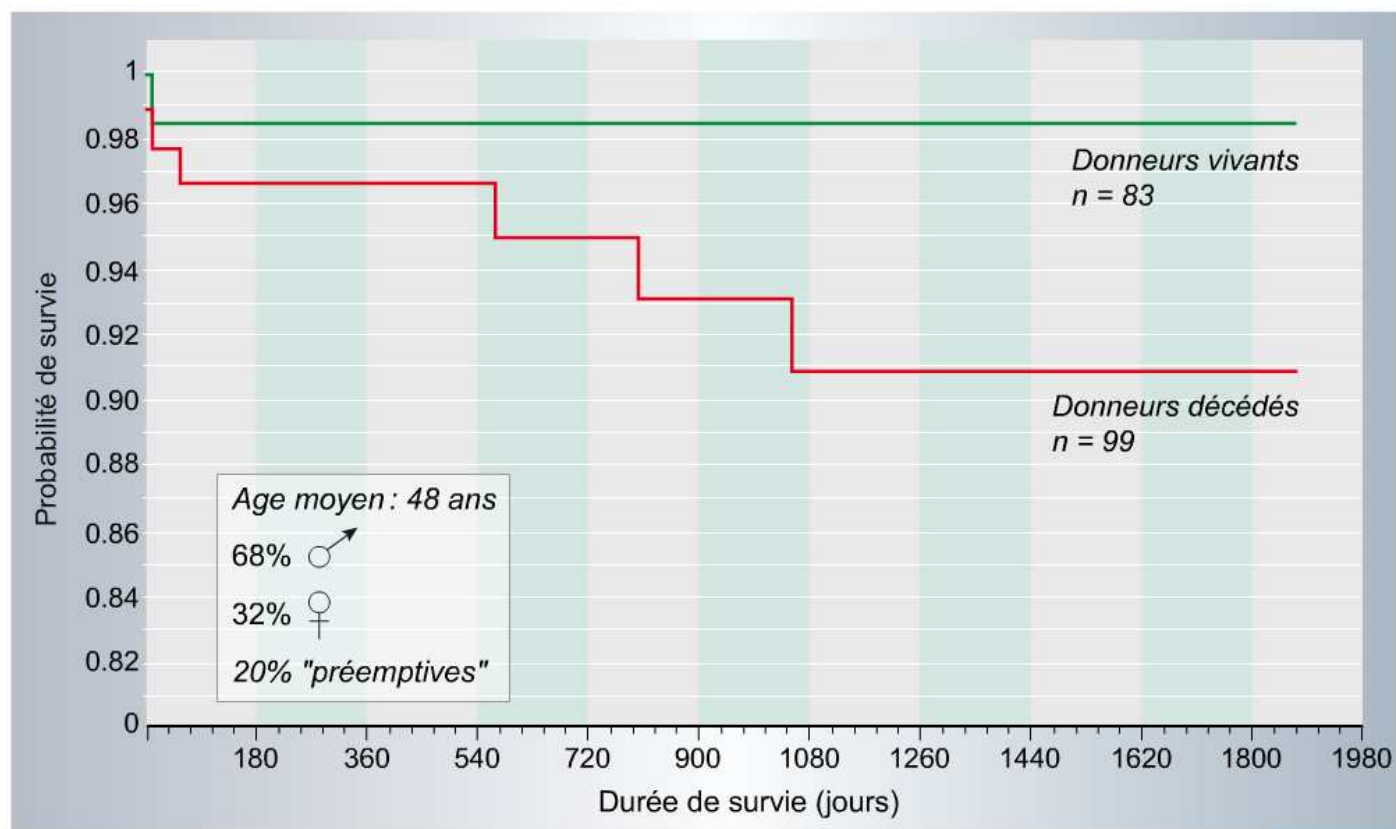
Transplantation rénale



Cohorte de transplantés rénaux du CHUV 2003-2008

Survie des greffons

Comment
améliorer
les résultats
à long-terme ?

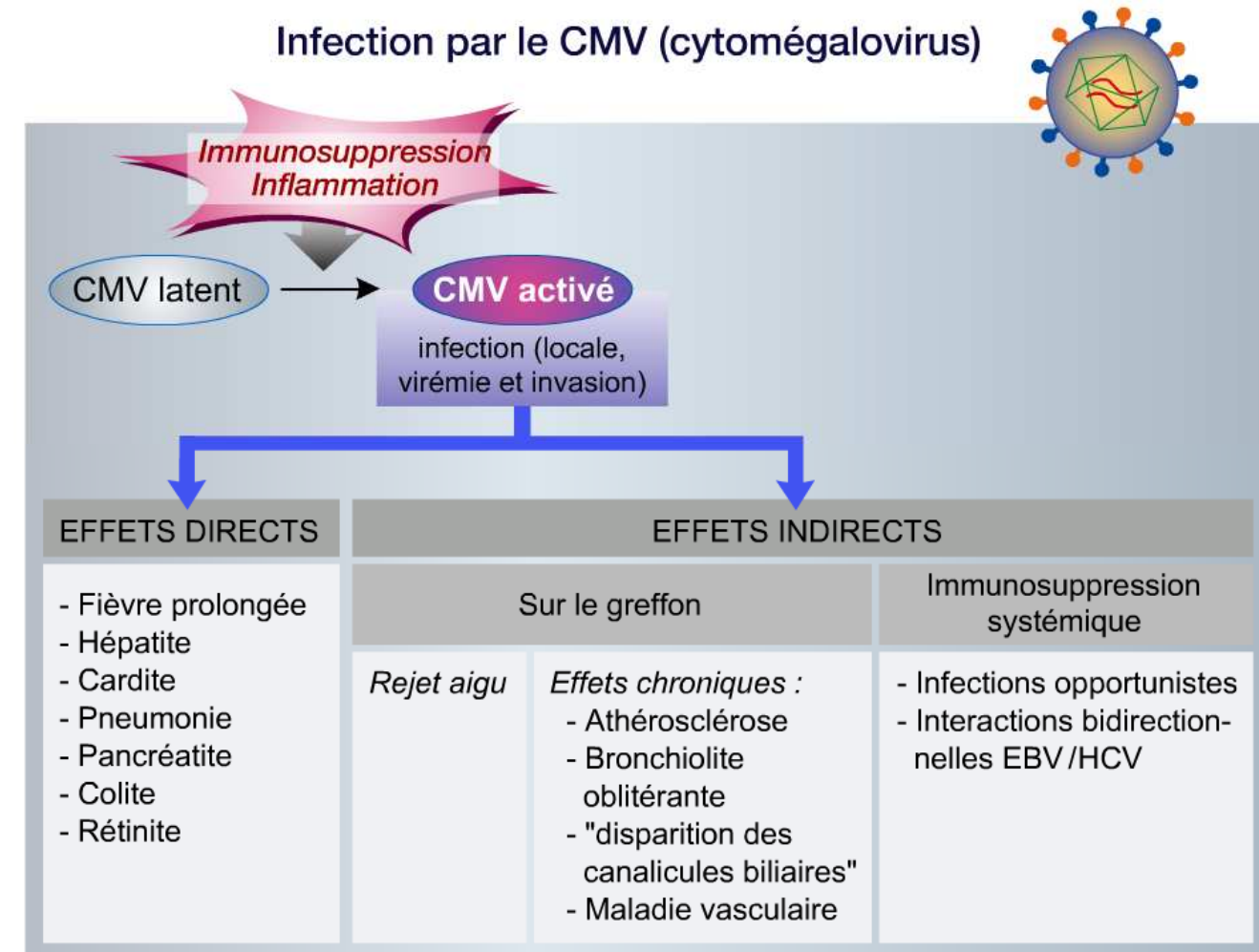


Dr. JP Venetz, CHUV (2010)

Transplantation rénale

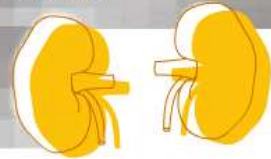


Prévention des infections: l'exemple du CMV



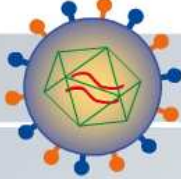
Adapté de Fishman JA, Rubin RH N Engl J Med 1998 ; 338 : 1741-51
et Fishman JA NEJM 2007

Transplantation rénale



La durée de la prophylaxie anti-CMV est généralement de 3 mois

Prévention
des infections:
l'exemple
du CMV

	Janv 00 - Mars 03	Avr 03 - Jul 05	
	3 mois VAL (pour les D+/R-) (n = 73)	3 mois VGC (pour tous les cas à risque) (n = 70)	Valeur p
Infection active nécessitant un traitement	30%	11%	0.007
Infection asymptomatique	22%	0%	0.001
Maladie à CMV	8%	11%	NS

VAL : Valaciclovir, VGC : Valganciclovir (antiviraux)

Données du Centre de Transplantation d'organes, CHUV, Lausanne

Meylan P and Pascual M. Clin Infect Dis 2006

Manuel O, Venetz JP, et al. Swiss Med Wkly 2007

Wasserfallen JB et al. Int J Tech Ass Health Care 2008

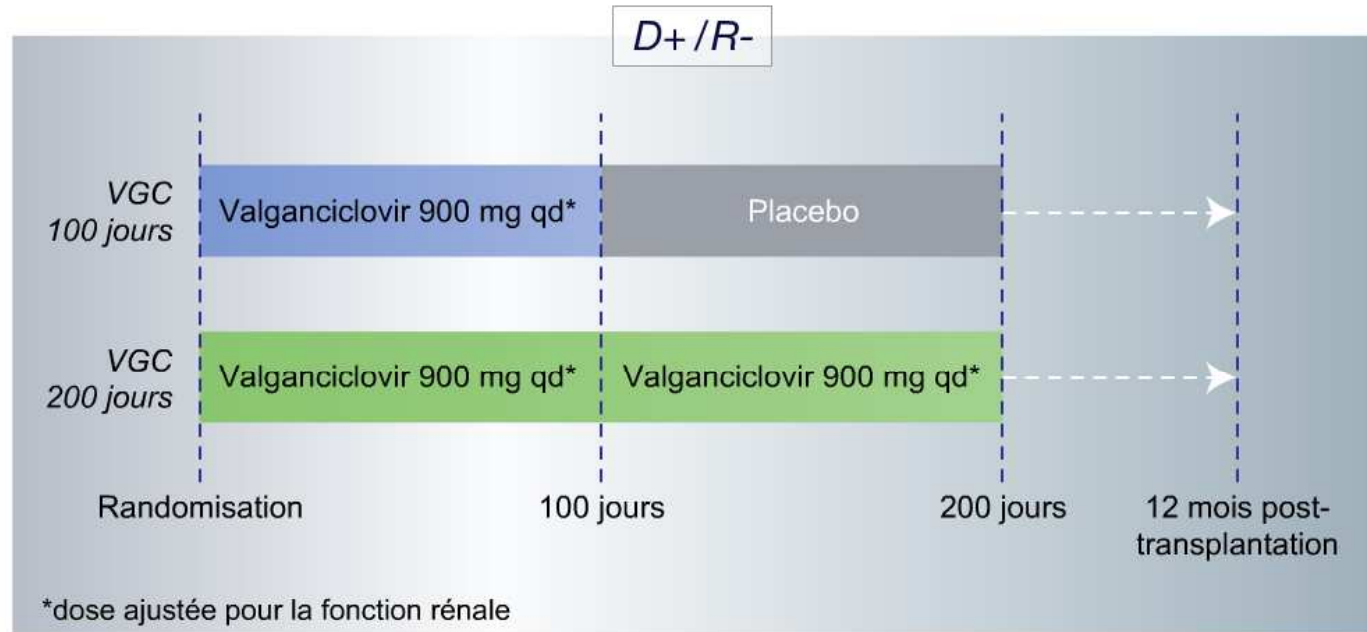
Transplantation rénale



Design

n = 326 patients à haut risque pour CMV

Prévention des infections: l'exemple du CMV



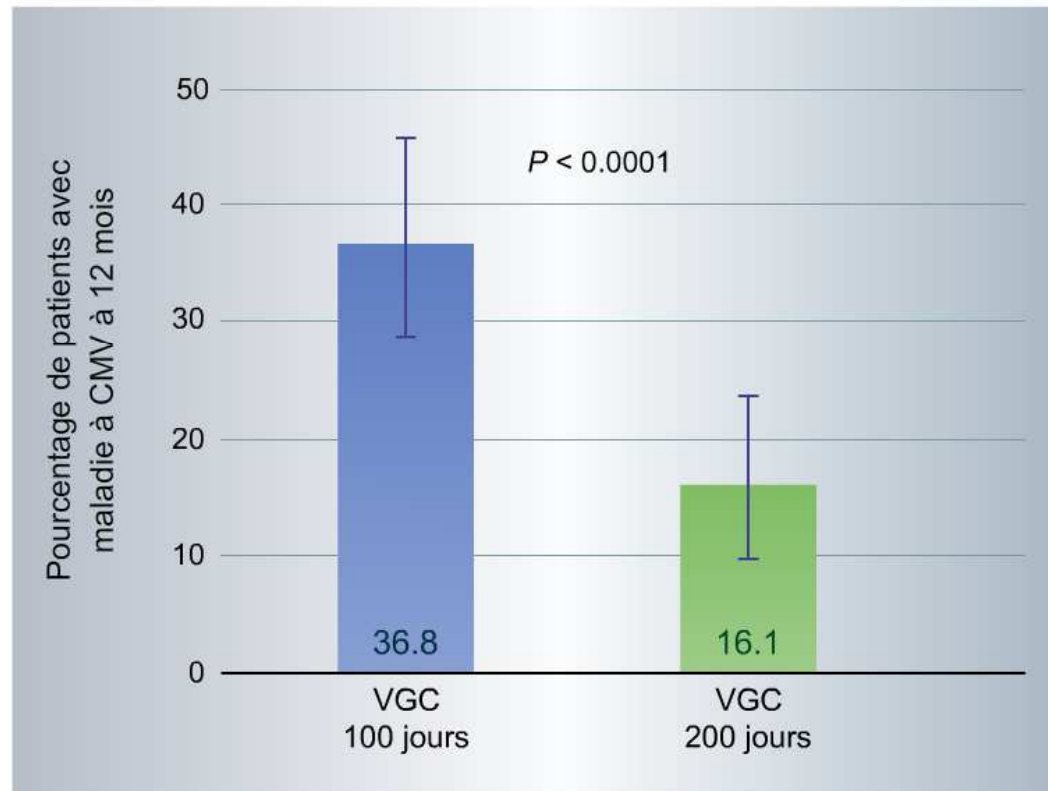
Humar A et al. Am J Transplant 2010 ; 10 : 1228-37

Transplantation
rénale



Maladie à CMV

Prévention
des infections:
l'exemple
du CMV

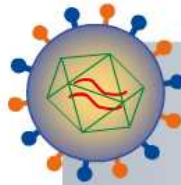


Humar A et al. Am J Transplant 2010 ; 10 : 1228-37

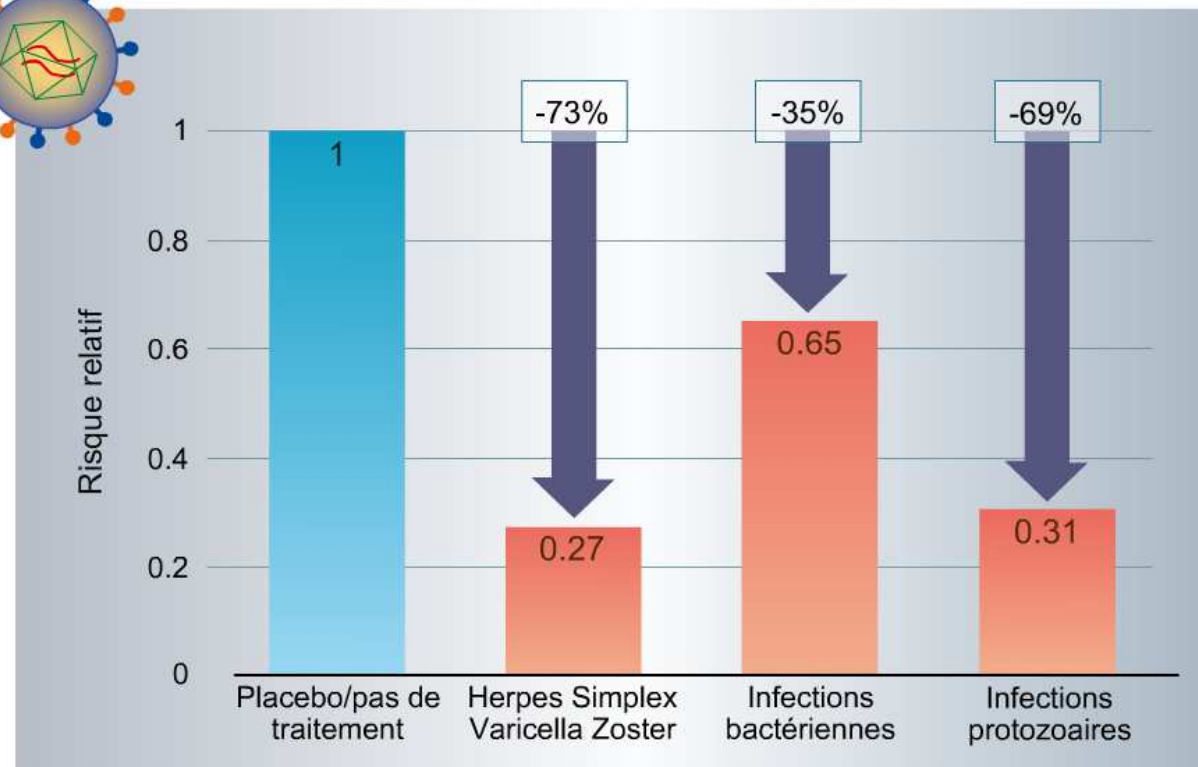
Transplantation
rénale



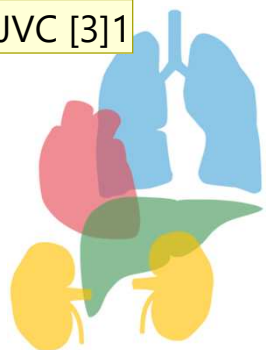
Prévention
des infections:
l'exemple
du CMV



Effets de prophylaxies anti-CMV sur des infections concomitantes



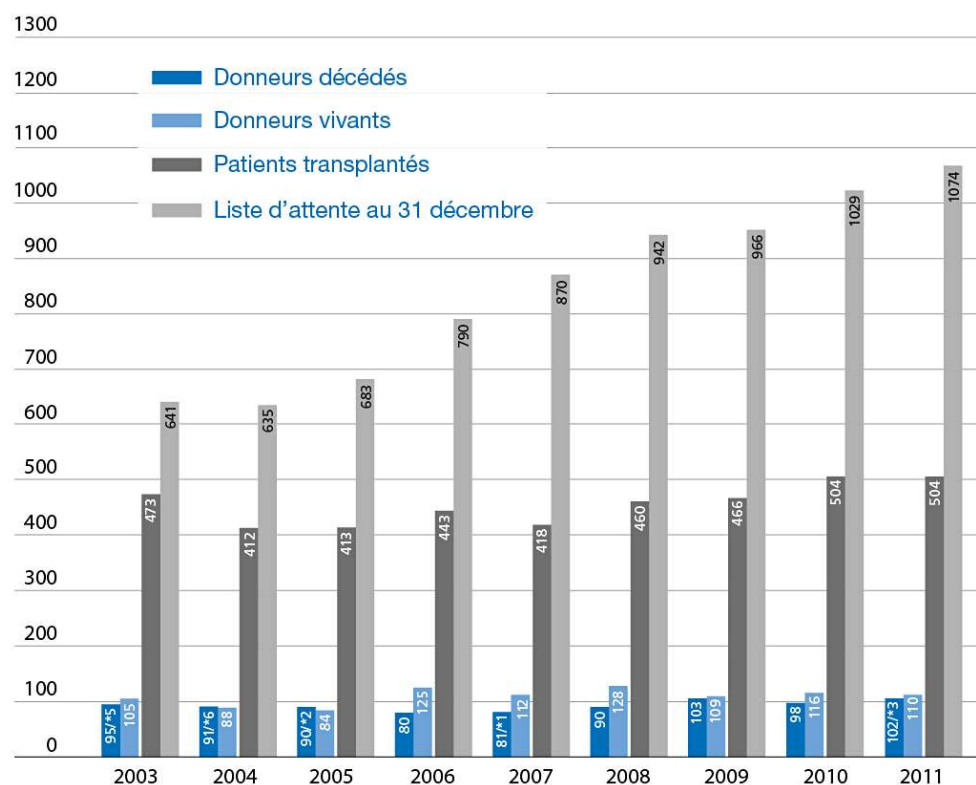
Hodson EM et al. Lancet 2005; 365:2105-15



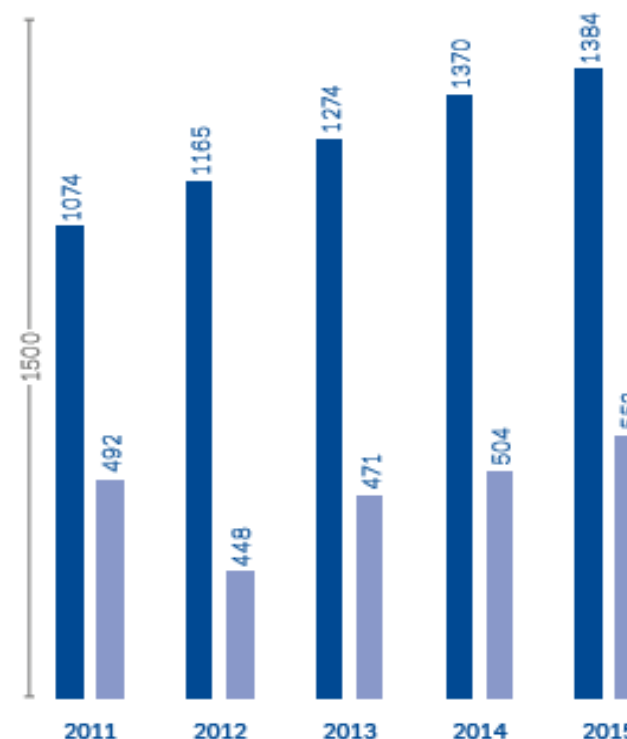
Pénurie d'organes et liste d'attente en Suisse (env. 2x plus en 12 ans)



Les patients en liste d'attente et patients transplantés
(sans les receveurs d'organes à l'étranger)



* dont les donneurs DCD



■ Patients en liste d'attente au 31 décembre
■ Patients transplantés

Diapositive 17

AJVC [3]1 Devrions-nous mettre les derniers chiffres de 2016 (cf. présentation PD Dr Immer) ?
Antonella Julien Vionnet Corcillo; 25.01.2017